3.1.1 입원환자 치료계획			
규 정 번 호	3.1.1	제 정 일	3주기 규정집 제정
관련 인증기준	3.1.1 입원환자 치료계획	최근 개정일	2025-10-15
담 당 부 서	진료부, 간호부	시 행 일	2025-11-01
검 토 책 임 자	병원 운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	2027-10-15
관 련 근 거			

▣ 목적 (Purpose)

환자의 특성에 따른 개별화된 치료계획을 세우고 환자의 상태 변화에 따라 재평가함으로써 환자에게 양질의 의료서비스를 제공한다.

▣ 용어 정의 (Definition)

· 치료계획 : 환자 평가결과에 따른 문제를 해결하기 위하여 의사가 치료 또는 중재를 제공하기 전에 체계적이고 효율적으로 세운 구체적인 계획

· 환자의 주요상태 변화 : 치료계획에 영향을 줄 수 있는 환자의 상태변화, 특수검사 결과, 처치, 침습적 시술 후 환자 상태의 변화 등을 의미한다.

· 간호과정(Nursing process) : 간호가 체계적이고 효율적으로 이루어질 수 있도록 간호 문제를 해결하는 일련의 체계적인 과정

▣ 정책 (Policy)

1. 의사는 환자의 치료계획을 수립한다.
2. 의사는 환자의 주요 상태변화 경과를 기록한다.
3. 의사는 환자의 치료계획을 재수립한다.
4. 간호사는 환자의 주요 상태변화에 따라 간호과정을 기록한다.
5. 환자 치료계획 및 간호과정을 관련 직원과 공유한다.
6. 환자에게 치료계획을 설명한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 의사의 진료 과정

가. 입원환자의 진료과정은 경과기록에 SOAP의 형식에 의해 작성한다.

1) S(Subjective information) : 주관적 정보
2) O(Objective information) : 객관적 정보
3) A(Assessment) : 분석평가
4) P(Plan) : 계획

나. 치료계획의 수립

1) 환자 치료가 체계적이고 효율적으로 이루어질 수 있도록 치료 또는 중재를 제공하기전에 환자의 요구를

파악하여 환자의 문제를 해결하기 위한 구체적인 치료계획(care plan)을 수립한다.

2) 입원 시부터 치료 또는 중재를 제공하기 전에 세우며, 경과기록지에 치료 계획을 수립한다.

3) 환자의 상태를 평가하고, 확인된 질환과 증상을 경과기록으로 작성한다. 앞으로의 진료계획을 세우고, 향후로 있을 변화를 평가하고, 진료의 지속여부를결정한다.

4) 수립된 치료계획을 제공하고, 모든 과정을 경과기록에 작성한다.

다. 환자의 주요상태 변화 시 치료계획의 재수립

의사는 치료과정 중 치료계획에 영향을 줄 수 있는 특수검사 결과, 처치 및 침습적 시술 후 환자상태의 변화가 있을 시 적합한 치료계획을 재수립 하고 경과기록지에 기록한다.

라. 정기적 치료계획 재수립

1) 환자상태 변화가 있을 시는 즉시 경과기록에 기록한다.

2) 장기입원환자는 경과에 특별한 변화가 없거나, 일정한 치료가 계속 유지되는 경우에도 최소 월 1회 이상 기록한다.

2. 간호사의 간호 과정

가. 간호사는 모든 입원환자 대상으로 간호문제 발생 시 간호의 과정을 적용하여 제공한 간호의 내용을 기록한다.

나. 환자의 상태변화가 없는 장기입원 환자의 경우 별도의 간호문제가 발생 하지 않을 시 7일(매주 금요일)마다 간호과정을 적용한다. 단, 환자의 상태변화 및 간호문제 발생 즉시 간호과정을 적용한다.

다. 그 외, 환자의 상태가 안정적이지 않거나 지속적 간호문제가 발생하는 환자의 경우 발생 시 마다 charting에 간호과정을 적용한다.

라. 간호 과정은 다음 내용을 포함한다.

1) Data, Action, Response 순서로 간호과정을 적용한다.

2) 관찰, 면담, 측정을 통해 환자의 주관적, 객관적 상태를 수집하고 수집된 자료를 분석하 여 대상자의 강점과 실제적, 잠재적 그리고 가능성 있는 건강문제를 파악한다(Data).

3) Data에 따라 환자가 기대되는 결과에 도달할 수 있도록 간호계획 및 중재를 시행하고기록한다(Action).

4) 환자의 상태변화 및 반응을 포함한 결과를 평가하고 그 후 문제가 해결될 때까지 재사정하고 평가한다(Response).

5) 구체적이고 간결하며 개인적 판단이나 편견을 배제한 법적으로 수용 가능한 언어를 사용하여 간호 과정을 기록한다.

6) 간호 과정은 순환과정이므로 모든 단계를 계속적으로 재검토해야 한다.

7) 간호 과정 기록은 용어가 전달될 수 있는 짧은 문장으로 기록한다.

8) 간호 과정 기록은 가능한 우리말로 기재하고 존칭어는 사용하지 않는다.

마. 환자의 상태변화와 의사의 치료계획에 따라 간호과정을 적용한다.

바. 일련의 간호 과정은 간호경과기록지에 기록한다.

사. 간호과정 기록은 환자진료를 담당하는 직원들과 공유한다.

3. 치료계획 정보 공유

가. 환자의 치료계획과 간호과정을 환자진료와 관련 있는 타 부서 또는 타 직종의 직원들과 필요 시 의무기록 접근 권한 안에서 공유한다.

1) 의사, 간호사, 영양사, 방사선사, 사회복지사, 물리치료사, 작업치료사가 작성한 의무기록은 상호간에 열람 할 수 있다.
2) 열람권한은 [11.1 의료정보/의무기록 관리] 규정에 따른다.

4. 환자 및 보호자에게 진료(치료계획)에 관한 정보 제공

가. 진단명(또는 추정진단)

1) 입원 시 추정진단명과 수술 후 진단명, 검사결과 등을 통하여 새로이 발견된 진단명, 합병증 등에 대한 정보를 제공한다.

나. 치료(또는 검사) 계획의 정보제공

1) 입원 시 예정된 치료(검사)계획에 대한 정보를 제공한다.
2) 환자의 상태변화를 주기적으로 재평가하여 재설정한 치료(검사)계획에 대한 정보를 제공한다.

다. 치료(또는 검사)에 따른 예상효과 및 위험에 대한 정보에 대해 환자 또는 보호자에게 설명후 경과기록에 기록한다.

▣ 규정 개정일 [누적]

2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일					